

Памятка пациенту: СИОЗС

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина — сертралин, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, циталопрам, флувоксамин

О чём эта памятка

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) — наиболее часто назначаемая группа антидепрессантов. К ним относятся: сертралин (Zoloft), эсциталопрам (Cipralex, Lexapro), флуоксетин (Prozac), пароксетин (Paxil), циталопрам (Cipramil), флувоксамин (Fevarin). Показаны при депрессии, тревожных расстройствах (ГТР, паническом, социальной тревоге), ОКР, ПТСР.

Как работают и когда ждать эффекта

СИОЗС увеличивают доступность серотонина в синаптической щели. Но настоящий терапевтический эффект связан не столько с самим серотонином, сколько с постепенной перестройкой рецепторов и нейропластичностью — поэтому эффект развивается не сразу.

Срок	Что происходит
1-3 дня	Возможны первые побочные эффекты (тошнота, тревога, головная боль). Терапевтического эффекта ещё нет.
1-2 недели	Побочные эффекты обычно ослабевают. Может улучшаться сон и аппетит.
2-4 недели	Начинает уменьшаться тревога и подавленность. Появляется способность «взглянуть на проблему со стороны».
6-8 недель	Полный терапевтический эффект. Если улучшения нет — врач обсуждает увеличение дозы или смену препарата.
6-12 мес.	Рекомендованная продолжительность лечения после первого эпизода (NICE, APA) — чтобы закрепить ремиссию.

Типичные стартовые и терапевтические дозы

Препарат	Старт	Терапевтическая	Макс.
Сертралин	25-50 мг	50-150 мг	200 мг
Эсциталопрам	5-10 мг	10-20 мг	20 мг
Флуоксетин	10-20 мг	20-40 мг	60-80 мг
Пароксетин	10-20 мг	20-40 мг	50-60 мг
Циталопрам	10-20 мг	20 мг	40 мг (20 мг >60 лет)
Флувоксамин	50 мг	100-200 мг	300 мг

Дозы приведены для взрослых. Конкретную схему определяет врач.

Что МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ

✓ Можно и даже нужно

- Принимать в одно и то же время каждый день (лучше утром, кроме пароксетина и флувоксамина — их часто вечером).
- Принимать с едой — уменьшает тошноту.
- Продолжать привычный образ жизни, работать, водить машину (см. раздел о вождении).
- Заниматься спортом, ходить в баню, летать на самолётах.
- Умеренно пить кофе (до 2–3 чашек в день).
- Сочетать с психотерапией — комбинация эффективнее монотерапии (NICE, APA).

✗ Нельзя категорически

- Зверобой (Hypericum) — сам является ингибитором обратного захвата серотонина, риск серотонинового синдрома.
- Триптаны (суматриптан и др.) при мигрени — только по согласованию с врачом, риск серотонинового синдрома.
- Трамадол, петидин, декстрометорфан — риск серотонинового синдрома.
- ИМАО — категорически противопоказано. Перерыв между ИМАО и СИОЗС должен быть не менее 2 недель (для флуоксетина — 5 недель).
- Резко бросать препарат — только постепенная отмена под контролем врача.
- Дублировать дозу, если забыли принять предыдущую.

! С осторожностью

- Алкоголь — не запрещён категорически, но усиливает седацию и снижает эффект лечения. В идеале — воздержаться. Допустимо: 1 бокал вина изредка при стабильном состоянии.
- НПВС (ибупрофен, диклофенак, аспирин) — повышают риск желудочных кровотечений. При длительном приёме — обсудить с врачом гастропротекцию.
- Грейпфрут и грейпфрутовый сок — повышают концентрацию сертралина через CYP3A4. Лучше избегать больших количеств.
- Антикоагулянты (варфарин, ривароксабан) — риск кровотечений выше.
- Оральные контрацептивы — совместимы, но могут менять уровни некоторых СИОЗС; обсудить с врачом.

Побочные эффекты и как реагировать

Ключевая мысль: большинство побочных эффектов появляются в первые 1–2 недели и проходят сами. Это НЕ признак «плохого» препарата.

Эффект	Что делать
Тошнота, тяжесть в желудке	Принимать с едой, дробное питание, имбирный чай. Обычно проходит за 5–10 дней.
Головная боль	Парацетамол при необходимости. Пить достаточно воды. Проходит за 1–2 нед.
Усиление тревоги в первые дни	Ожидаемо. Врач может временно назначить «прикрытие» (гидроксизин, короткий курс бензодиазепинов). Не отменяйте препарат сами.
Сонливость / бессонница	Сонливость → принимать вечером. Бессонница → утром. Обсудить с врачом.

Эффект	Что делать
Снижение либидо, отсроченный оргазм	Частый эффект (до 30–70%). Иногда уменьшается со временем. Варианты: пауза дозы (не самостоятельно!), смена на бупропион, вортиоксетин или добавление к терапии.
Потливость	Обычно нестойкая. Лёгкая одежда, водный режим.
Изменения веса	Пароксетин чаще всего вызывает прибавку веса. Сертралин, эсциталопрам — нейтральны или незначительная прибавка при длительном приёме. Флуоксетин — часто нейтрален или снижает вес в начале.
Эмоциональное «уплощение»	Иногда возникает на средних-высоких дозах. Сообщите врачу — может помочь снижение дозы или смена на вортиоксетин/бупропион.
Диарея / запор	Обычно проходит. Клетчатка, вода. Если сохраняется > 2 недель — к врачу.

⚠ Когда СРОЧНО связаться с врачом или вызвать скорую (103 / 112)

- Мысли о самоповреждении или суициде, особенно с планом.
- Резкое возбуждение, ажитация, спутанность сознания.
- Высокая температура + мышечная ригидность + потливость + дрожь + тахикардия (подозрение на серотониновый синдром).
- Сильная сыпь, отёк лица/губ, затруднённое дыхание (аллергия).
- Кровотечения: длительное носовое, кровь в стуле, обильные синяки.
- Судороги, обморок, необычно медленный или частый пульс.
- Резкое усиление тревоги/панические атаки в первые 1–2 недели (может потребоваться коррекция дозы или временное «прикрытие»).

Вождение автомобиля и работа с механизмами

СИОЗС в стабильной терапевтической дозе не запрещают вождение. Более того, нелеченая депрессия и тревога сами по себе снижают внимание и повышают риск ДТП (мета-анализ Hill et al., 2017; обзоры van der Sluiszen, 2021).

- Первые 1–2 недели и при повышении дозы — воздержаться от длительного вождения (возможны сонливость, головокружение).
- Пароксетин и флувоксамин седируют сильнее — лучше вечерний приём и осторожность утром.
- Алкоголь + СИОЗС + руль — категорически нельзя.
- Если чувствуете сонливость или замедленную реакцию — за руль не садиться.

Беременность и планирование

Депрессия и тревога во время беременности сами по себе опасны для матери и плода (риск преждевременных родов, низкого веса, послеродовой депрессии). Решение об АД принимается индивидуально с врачом.

✓ Относительно безопасные при беременности (СИОЗС)

- Сертралин — препарат первого выбора при необходимости начала терапии во время беременности (наибольший объём данных, наименьший переход через плаценту среди СИОЗС).
- Эсциталопрам и циталопрам — приемлемая альтернатива.
- Флуоксетин — большой массив данных, допустим, но длительный период полувыведения.

Источники: ACOG 2023, NICE CG192 (обновл. 2020), CANMAT, MotherToBaby, консенсус Eleftheriou et al., 2023.

✗ Избегать при беременности

- Пароксетин — ассоциирован с небольшим повышением риска пороков сердца плода (FDA категория D по старой классификации). Если пациентка уже принимает и ремиссия стабильна — вопрос решается индивидуально.
- В III триместре возможен транзиторный неонатальный синдром адаптации (раздражительность, дыхательные нарушения) — обычно проходит за несколько дней, не требует отмены.

Грудное вскармливание

✓ Совместимые с грудным вскармливанием

- Сертралин — препарат первого выбора (минимальные уровни в грудном молоке, LactMed).
- Пароксетин — также с минимальным переходом в молоко (но избегать назначения во время беременности).
- Эсциталопрам / циталопрам — приемлемо, уровни выше, но клинически значимых эффектов у детей не описано.
- Флувоксамин — низкие уровни в молоке, данных меньше, но совместим.

Флуоксетин — переходит в молоко сильнее других (длинный период полувыведения); при выборе de novo предпочтительны сертралин или пароксетин.

Источники: LactMed (NIH), Den Besten-Bertholee 2024, ABM Protocol, UK Specialist Pharmacy Service 2023.

Отмена препарата и синдром отмены

СИОЗС не вызывают зависимости в наркологическом смысле (нет тяги, роста доз, «ломки» как таковой). Но при резком прекращении возможен синдром отмены — временное недомогание из-за перестройки серотониновой системы.

- Возможные симптомы: головокружение, «электрические разряды» в голове (brain zaps), тошнота, гриппоподобное состояние, раздражительность, яркие сновидения. Появляются через 1–3 дня после пропусков, длятся 1–2 недели.
- Наиболее часто — при пароксетине и венлафаксине (из СИОЗСН). Реже всего — при флуоксетине (длинный $T_{1/2}$).
- Правильная отмена — постепенно, снижая дозу на 25% каждые 2–4 недели. Для пароксетина и при длительном приёме > 1 года — может понадобиться «гиперболическое» снижение по 10% (Horowitz & Taylor, Lancet Psychiatry 2019).
- Никогда не отменяйте препарат самостоятельно — обсудите с врачом.

Развенчание мифов

Развенчание мифов

Миф: «Антидепрессанты вызывают зависимость»

На самом деле: Нет. Это не наркотики, нет тяги и роста толерантности. Может быть синдром отмены при резком прекращении — это другое: организм адаптируется обратно, а не «требуется» препарат.

Миф: «Они меняют личность»

На самом деле: Нет. Они убирают симптомы болезни (тревогу, апатию, руминации), возвращая человеку его собственный характер. Многие пациенты говорят: «я снова стал собой».

Миф: «Их придётся пить всю жизнь»

На самом деле: Обычно нет. При первом эпизоде — 6–12 месяцев после ремиссии. При повторных эпизодах курс длиннее. Пожизненно — только у меньшинства с частыми рецидивами.

Миф: «Они «отупляют» и делают овощем»

На самом деле: В правильной дозе — нет. Возможное эмоциональное уплощение обратимо и решается коррекцией схемы.

Миф: «Это «химия», надо лечиться травами»

На самом деле: Зверобой — тоже химия и тоже с побочными эффектами и взаимодействиями (сильный индуктор CYP450, снижает эффект контрацептивов, антикоагулянтов и др.). При этом уступает СИОЗС по эффективности при умеренной и тяжёлой депрессии.

Миф: «Если стало лучше — можно бросить»

На самом деле: Улучшение — это работа препарата. Ранняя отмена = высокий риск рецидива (до 50–70% в первый год).

Частые вопросы

? Частые вопросы (FAQ)

Что делать, если забыл принять таблетку?

Принять сразу, как вспомнили. Если уже близко к следующей дозе — пропустить забытую и продолжать как обычно. НЕ удваивать дозу.

Можно ли пить алкоголь?

Лучше воздержаться, особенно в первые недели. При стабильном состоянии допустим 1 бокал вина изредка. Крепкий алкоголь и запои — категорически нельзя.

Через сколько появится эффект?

Первые сдвиги — через 2 недели, полный эффект — через 4–8 недель. Если через 4 недели никаких улучшений — сообщите врачу.

А если мне не помогает?

До 40% людей не отвечают на первый СИОЗС. Это не тупик: врач подберёт другой препарат или комбинацию. Терпение и коммуникация — ключ.

Можно ли делать прививки?

Да, все прививки совместимы с СИОЗС.

Можно ли сдавать анализы, делать МРТ, наркоз?

Да. Обязательно сообщите анестезиологу о приёме СИОЗС (влияет на выбор препаратов, риск кровотечений).

Что если я забеременела на СИОЗС?

Не паникуйте и не отменяйте сами. Свяжитесь с врачом — обычно приём продолжают (особенно сертралин) или корректируют схему.

Могу ли я быть донором крови?

Приём СИОЗС не является абсолютным противопоказанием, но уточните в конкретном центре донорства.

Питание и образ жизни

Антидепрессант работает лучше, если помогать ему извне. Ниже — то, что имеет доказательную базу (не БАДы, не «волшебные» диеты).

Питание

- Средиземноморский тип питания (овощи, рыба, оливковое масло, бобовые, цельные злаки, орехи) — единственный тип питания с доказанным умеренным антидепрессивным эффектом (SMILES trial, 2017; PREDIMED).
- Омега-3 (жирная рыба 2 раза в неделю) — вспомогательный эффект при депрессии, особенно EPA-обогащённые формы.
- Регулярность приёмов пищи: пропуск еды усиливает тошноту и головокружение от многих АД.
- Достаточно воды (1,5–2 л/сут) — уменьшает сухость во рту и запоры.

Кофеин и энергетики

- До 200–300 мг кофеина в сутки (2–3 чашки кофе) — обычно безопасно.
- При выраженной тревоге и бессоннице лучше отказаться от кофе после 14:00.
- Энергетики и предтренировочные комплексы нежелательны — содержат высокие дозы кофеина и стимуляторов, усиливают тревогу и сердцебиение.

Сон

- Ложиться и вставать в одно и то же время (± 30 мин), даже в выходные.
- Экран за 30–60 минут до сна — выключить. Синий свет подавляет мелатонин.
- Если препарат бодрит (флуоксетин, венлафаксин, бупропион) — принимать утром. Если седатирует (миртазапин, тразодон, амитриптилин, пароксетин) — вечером.

Физическая активность

- 150 минут аэробной нагрузки в неделю (быстрая ходьба, плавание, велосипед) — эффект сопоставим с лёгкими формами депрессии на монотерапии (Cochrane, 2013; meta-analyses 2023).
- Силовые тренировки 2 раза в неделю — дополнительный эффект на тревогу и самооценку.
- Начинать с малого: 10 минут в день — уже работает.

Дисклеймер. Этот документ — информационная памятка, а не медицинская инструкция. Все решения о начале, изменении дозы и отмене препарата принимаются только совместно с лечащим врачом. Материал подготовлен на основе современных источников: NICE NG222 (2022–2024), APA Practice Guidelines, WFSBP, Maudsley Prescribing Guidelines (14-е изд.), NIH LactMed, MotherToBaby, Cochrane Reviews.